Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n° 0809964-07.2019.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

Thaisa Munike Costa de Oliveira, já qualificada na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência em desfavor de **Unimed Dourados Cooperativa de Trabalho Médico** , também qualificada, para custeio de procedimento cirúrgico. Narra que está na 25.ª semana de gravidez e foi diagnosticada com gestação gemelar monocorionica/diamniotica, com necessidade de procedimento cirúrgico intrauterino de urgência para evitar a morte dos fetos pois um deles é acardíaco. Relata que sem especialista em Dourados/MS, foi encaminhada ao médico Dr. Renato Ximenes, em Campinas/SP, que indicou a cirurgia no Hospital Madre Theodora, na mesma cidade não obteve do plano réu para a cobertura após ter submetido a documentação. Pede a concessão de tutela urgência para obrigar a ré a custear o procedimento cirúrgico e ao final, a procedência dos pedidos iniciais e sua condenação nos ônus sucumbenciais (f. 1-28). Instruiu a inicial com documentos (f. 29-107).

Determinação de emenda da inicial (f. 109), cumprida pela autora às f. 110-4. Anexou documentos (f. 115-24).

Deferimento da tutela de urgência e benefícios da justiça gratuita (f. 125-31).

Intimação da parte ré para cumprimento da tutela de

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

urgência em 24 horas (f. 164).

Em contestação, Unimed de Dourados – Cooperativa de Trabalho Médico afirma que autorizou o procedimento em sua rede credenciada, entretanto, a autora buscou atendimento por conta própria, sem prévia solicitação, em prestador não credenciado. Aduz que o plano de saúde não permite a livre escolha de médicos e estabelecimentos de saúde, com autorização somente em casos de indisponibilidade ou existência de rede assistencial. Aduz a inexistência de requisitos para o reembolso, pois não houve solicitação para o procedimento, caso contrário que seja respeitado o limite de preços praticados pela rede. Insurge-se com os danos morais por ausência de recusa. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos (f. 170-86). Acostou documentos (f. 187-281).

Impugnação à contestação (f. 284-301).

Decisão saneadora (f. 302).

Manifestação da ré pela prova pericial (f. 307).

Informação da parte ré de cumprimento da tutela de urgência de reembolso no limites de valores de sua rede credenciada (f. 322-25). Juntou documentos (f. 326-51).

Ofício do TJMS (f. 365), com comunicação das decisões de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento oposto pela parte ré pelo TJMS (f. 366-77), agravo interno cível (f. 380), embargos de declaração (f. 382-4), recurso especial (f. 386-91), agravo em recurso especial (f. 395-6) e embargos de declaração no agravo em recurso especial (f. 415-8).

Laudo pericial (f. 511-41).

Impugnação do laudo pericial pela autora, com pedido de esclarecimentos (f. 545-57). Carreou documentos (f. 558-9).

Concordância com o laudo pela parte ré (f. 561-3). Juntou laudo do assistente técnico (f. 564-70).

Esclarecimentos do perito judicial (f. 573-5).

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

Pedido da autora de nulidade do laudo e pela prova testemunhal (f. 583-99).

Manifestação do perito (f. 606-15).

Audiência de instrução, com oitiva de testemunha (f. 624).

Alegações finais da autora, pela nulidade do laudo pericial e procedência dos pedidos (f. 625-33).

Alegações finais da requerida, pela descaracterização da urgência/emergência para atendimento fora da rede credenciada e improcedência dos pedidos (f. 634-8).

É o relatório.

Decido.

A questão posta em julgamento é sobre obrigação de plano de saúde em reembolsar valores gastos com procedimento cirúrgico por profissional médico e em hospital não credenciado, além de danos morais.

I) Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

Por se tratar de avença entre pessoa física e plano privado de assistência à saúde cabível a aplicação do CDC. A relação entre as partes é de consumo e a ré deve ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, vejamos o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990"*. Nesse sentido já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

> *10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo*** *. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019).

A atividade fim da ré é assegurar tratamento médico assim que dele se necessite, logo, é prestadora de serviços e a relação é de consumo, com aplicação do CDC. Importa ressaltar que a inexistência de cláusulas abusivas, ao contrário do dito pela ré, não afasta a aplicação da Lei Consumerista, implica somente na manutenção dos termos da avença.

II) Do reembolso:

A autora teve indicação cirúrgica para realização de procedimento de laser intersticial em feto acárdico (sem coração) o mais rápido possível (até 72 horas) diante de condições clínicas severas, decorrentes de desequilíbrio que afeta o feto "bomba", aumento do volume do líquido aminiótico e desconforto respiratório materno, além de ocasionar a ruptura da bolsa e eventualmente a perda da gestação ou parto prematuro extremo, pela idade gestacional inferior a 28 semanas, de acordo com a justificativa apresentada pelo médico assistente Dr. Renato Ximenes (f. 76):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Prof. Dr. Renato Ximenes
Membro Comissão US CBR
Diretor Fundação Medicina Fetal Latinoamericana - FMFLA
CRM 65.975

JUSTIFICATIVA PARA A PROCEDIMENTO DE LASER INTERSTICIAL

No dia 21/08/19 avaliamos a SRA. Sra. Tahis Munike Costa de Oliveira sendo diagnosticado por Ultrassonografia um caso de Gestação Gemelar Monocorionica/Diamniotica, com feto 1 a direita e denominado feto Acárdico não apresentando cabeça (polo cefálico), não apresentando coração, com edema de tecido celular subctaneo e áreas cisticas septadas, send visualizado área inserção do cordão umbilical para o interior da massa associado a aparente herniação das alças junto ao cordão umbilical (onfalocele), presença de membros. Feto 2 à esquerda com morfológica de aspecto usual, Peso Fetal = 778 gramas (percentil 32,79), compatível com 25 semanas e 5 dias, Gestação Monocoriônica/Diamniótica.

Como descrito acima à conduta expectante leva a morte o Feto doador (feto saudavel) em 50-75% dos casos. Sendo assim conversamos com o casal e oferecemos a realização de Laser Intersticial no feto acardico o mais rápido possível visto que as condições clinicas fetais já se encontram severas visto o tamanho do feto acárdico em associação com Polidramnio que demonstra um desiquilíbrio importante, que afeta de forma extremamente significatica o feto "bomba" este que buscamos oferecer uma melhora do seu estado hemodinâmico intrautero e também que possamos conseguir levar a gestação o mais longe possível evitando parto prematuro e sequelas neurológicas.

Em geral o tratamento para este tipo de condição já é oferecido nos Centros de Referência mundialmente à partir de 16 semanas. Neste caso houve segundo relatos da paciente um agravo muito significativo do aumento do abdome materno relacionado a um aumento significativo do volume liquido amniótico, que leva a um desconforto postural e respiratório materno importante, que também pode ocasionar a qualquer tempo a rotura da bolsa amniótica e por conseguinte a perda da gestação visto a idade gestacional abaixo de 28 semanas considerado como prematuro extremo.

A paciente foi esclarecida quanto às vantagens e os riscos da cirurgia fetal do Laser Intersticial. Por enquadrar-se nos critérios de inclusão para Cirurgia fetal Laser Intrafetal, a paciente e seu cônjuge solicitaram a realização da cirurgia fetal que deverá ser realizada o mais rápido possível dentro de 24-72 horas.

Nosso objetivo é a realização deste procedimento seja realizado em até 72 horas, visto risco eminente de rotura das membranas no Hospital Vera Cruz, na cidade de Campinas.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Av. Francisco Glicério, 2132 - Campinas - SP Tel: 19-2102-6933 - 19-99191-0995 email: rximenes@gmail.com

O artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, garante o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário quando não for possível a utilização dos serviços oferecidos pelos profissionais da rede credenciada, desde que sejam realizadas em casos de urgência e emergência e dentro dos limites das obrigações contratuais. Vejamos:

> *"Art. 12. (...)*
> *VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em* ***casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,*** *de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;"* (grifei)
> (...)
> *Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento*

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II- de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;".

O contrato de prestação de serviços médicos hospitalares do plano Unisaúde co-participativo simples de f. 249-72, do qual a autora é conveniada, prevê a possibilidade de reembolso nas situações de emergência/urgência (f. 262-3):

Reembolso de Despesas nas Emergências/Urgências

Nos atendimentos de urgência e emergência, é garantido ao beneficiário reembolso das despesas efetuadas com assistência à saúde, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º da Lei 9656/98, nos limites das obrigações contratuais, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela **CONTRATADA**, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

Os reembolsos devem ser solicitados mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Notas Fiscais e recibos de pagamento das despesas de Urgência/Emergência; Relatório Médico detalhado do médico assistente, fundamentando a ocorrência da Urgência/Emergência.

O beneficiário tem o prazo de 1 (um) ano para apresentar a documentação acima listada, caso assim não proceda estará prescrito seu direito a reembolso das despesas.

O valor a ser reembolsado será o da relação de serviços médicos e hospitalares praticados pela **CONTRATADA** junto à rede assistencial deste plano.

No caso dos autos, o médico assistente, Dr. Renato Ximenes, em 21.8.2019, apontou que o procedimento deveria ser realizado o mais rápido possível, dentro de 24-72 horas, diante do risco eminente de rotura das membranas, com a indicação do Hospital Vera Cruz, em Campinas/SP (f. 71-6).

Na mesma data, através de e-mail, a autora solicitou ao plano de saúde réu a cobertura do procedimento (f. 78-81), com a indicação para realização do procedimento, em 22.8.2024, pelo médico Rafael Frederico Burns, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba/PR (f. 118)

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

De: silas <silas@unimeddourados.com.br>
Enviado: Thursday, August 22, 2019 6:28:22 PM
Para: 'Thaisa Munike' <thaisamunike@hotmail.com>
Assunto: Resposta referente a solicitação de procedimento de CIRURGIA FETAL LASER INTERSTICIAL

Boa tarde Sra. Thaisa Munike Costa de Oliveira,

Servimo-nos do presente para, em atendimento a Vossa solicitação via e-mail datado de 21 de agosto de 2019 às 16h35mnts, esclarecer sobre o seu procedimento e solicitação, bem como, **AUTORIZAR O PROCEDIMENTO SOLICITADO**, nos termos do contrato e da Lei 9656/98, conforme abaixo delineado:

Conforme é de seu conhecimento, Vossa Senhoria não apresentou nenhum encaminhamento médico dos atendimentos e solicitação indicando o Dr. Renato Ximenes – CRM/SP n° 65975, para o procedimento solicitado.

No mesmo sentido, Vossa Senhoria não buscou em nenhum outro momento a sua Operadora de plano de saúde para as providencias necessárias às suas necessidades médica assistencial, em especial o procedimento solicitado.

Registre-se que o relatório anexado ao seu e-mail titulado como "RELATÓRIO DE ACONSELHAMENTO EM MEDICINA FETAL", não substitui a necessária apresentação de indicação obstétrica na realização do procedimento.

A impressão que fica é que Vossa Senhoria por livre arbítrio, após receber eventual laudo de ultrassom com registro de hipótese diagnostica de má formação, decidiu por conta e risco procurar o Dr. Renato Ximenes, médico este não credenciado a Rede assistencial da sua Operadora de plano de saúde.

Mesmo em tais condições, que por uma linha de analise direta, o procedimento esta totalmente fora dos termos do contrato de plano de saúde do qual Vossa Senhoria encontra-se vinculada a esta Operadora, e ainda que o procedimento de CIRURGIA FETAL LASER INTERSTICIAL não constar como de coberturas obrigatórias no Rol de Procedimentos editados pela ANS – RN 428/2017, atento a boa fé contratual e o principio social da sua relação com esta Operadora, comunicamos que o procedimento solicitado (Cirurgia fetal laser intersticial) **ESTÁ AUTORIZADO DENTRO DA REDE ASSISTENCIAL DESTA OPERADORA**, abaixo descrita:

Curitiba – PR

Dr. Rafael Frederico Bruns
Rua Chile, 1335
Prado Velho
Tel. (41) 3087-7500

Hospital Nossa Senhora Das Graças
Rua Alcides Munhoz, 433
Merces
Tel. (41) 3240-6060

Esclarecemos que em caso de haver qualquer dificuldade no contato ou atendimento com os prestadores supra referidos, favor entrar em contato direto no telefone (67) 3416 3590, falar com nossos coordenadores Andréia Pincela ou Silas.

Mas uma vez registramos que estamos a disposição para lhe assistir no que for necessário.

Att.
Silas Diego
Setor De Atendimento
UNIMED DOURADOS
Tel. 3416 3590

Em exame de amniocentese realizado em 21.8.2019, mesma data da consulta com o Dr. Ricardo Ximenes, em Campinas/SP, foi recomendado a autora, repouso absoluto, pelo alto risco de ruptura das membranas e consequente parto prematuro (f. 124):

1 - Realizado Amniocentese sob monitorização ecográfica contínua. Procedimento sem intercorrencias. Foi aspirado 20-40 ml de liquido amarelo claro.
2 - Material encaminhado para Estudo Cariotipo Fetal no laboratorio Prof. Walter Pinto Jr.
3 - Realizado Amniodrenagem para redução paliativa do volume Liquido Amniotico, sendo aspirado cerca de 650 ml de liquido amarelo claro, sem intercorrencias. Paciente relatou melhora na parte respiratoria após procedimento. *Paciente deve permanecer em repouso absoluto* e evitar ingestão de café e produtos que contenham cafeina, devido alto risco de rotura das membranas e conseguinte Parto Prematuro pois nessa idade gestacional este feto é considerado feto Prematuro Extremo (Peso fetal < 900 gramas).
4 - Foi indicado Cirurgia Fetal que deve ser realizado em até 72 horas, devido a gravidade do caso.

Atenciosamente,
Dr. Renato Ximenes - CRM 65.975

Desse modo, a despeito do laudo pericial de f. 511-41, que concluiu que o procedimento não era de emergência/urgência, tais fatorem indicam o contrário, ante ao prazo exíguo para realização o procedimento (até 72 horas), a necessidade de repouso absoluto, o risco de vida envolvido para autora e os gêmeos.

O **expert** informou no laudo pericial, em resposta ao quesitos nº 8 e 9 (f. 526-7):

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

8) Qual o procedimento indicado neste caso?
Resposta: FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DISPONIVEL BIBLIOGRAFICAMENTE.

O procedimento indicado em casos de gestação gemelar com gêmeo acárdico é complexo e deve ser personalizado para cada situação. O acompanhamento deve ser feito por uma equipe médica especializada em medicina fetal. Aqui estão algumas abordagens gerais:

1. **Monitoramento Regular**: A gestante deve ser submetida a exames ultrassonográficos seriados para monitorar o desenvolvimento dos fetos e a saúde da mãe[1].
2. **Diagnóstico Pré-Natal**: O diagnóstico é realizado pela ultrassonografia morfológica fetal, que inclui critérios como gestação gemelar monocoriônica, fluxo reverso no cordão umbilical e aorta descendente, presença de anastomoses arterioarteriais e ausência parcial ou completa do coração em um dos fetos[1].
3. **Intervenção Cirúrgica**: Em alguns casos, pode ser indicada a intervenção cirúrgica fetal para interromper o fluxo de sangue para o gêmeo acárdico. Isso pode ser feito através de técnicas como fetoscopia com coagulação dos vasos do cordão[2].
4. **Manejo das Complicações**: Se houver sinais de insuficiência cardíaca progressiva no gêmeo normal ou outras complicações, a equipe médica pode considerar intervenções específicas para tratar essas condições[2].

5. **Decisão sobre o Parto**: A decisão sobre o momento e o método do parto deve ser cuidadosamente avaliada, levando em conta a saúde da mãe e dos fetos, bem como a viabilidade do gêmeo acárdico.

É crucial que qualquer suspeita ou diagnóstico de gêmeo acárdico seja gerenciado por profissionais com experiência em gestações de alto risco e medicina fetal. A comunicação clara e o consentimento informado da gestante são fundamentais em todo o processo.

http://www.rb.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3022&idioma=Portugues
https://www.isuog.org/static/uploaded/4534724b-a9c9-4c59-810c5bdf8c7b5500.pdf
https://www.gestarcmf.com.br/sequencia-trap/

9) Qual é o momento correto para se realizar o procedimento?
Resposta: Quesito já respondido.

Sobre o risco de ruptura da bolsa amniótica repisou (f. 532-3):

18) O risco de ruptura poderia ser considerado a partir de qual momento?
Resposta: FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DISPONIVEL BIBLIOGRAFICAMENTE.

O risco de ruptura prematura da bolsa amniótica em gestações de gêmeos acárdicos pode ser considerado a partir de qualquer momento após a 20ª semana de gestação, que é quando a condição de ruptura prematura das membranas (RPM) pode ocorrer[1]. No entanto, é mais comum que o risco aumente à medida que a gravidez avança, especialmente em gestações múltiplas, onde o útero está mais distendido[2].
A gestação de gêmeos acárdicos já é uma condição de alto risco por si só, e a vigilância médica é essencial para monitorar sinais de possíveis complicações. A RPM pode levar a parto prematuro e outras complicações sérias, por isso é importante que qualquer sinal de

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

vazamento de líquido amniótico seja avaliado por um profissional de saúde imediatamente.

https://minutosaudavel.com.br/bolsa-rota/

Dispõe o artigo 479, do CPC, que o juízo não está vinculado às conclusões do laudo médico pericial, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos para formar sua convicção.

A avaliação deve ser feita de acordo com o conjunto probatório, a permitir que o juiz sopese todas as provas colacionadas aos autos para formar seu convencimento, além de se valer das máximas de experiência, sem que prevaleça para a motivação da sentença somente a prova pericial. Colhe-se seguinte julgado do E. TJMS sobre o tema:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CONFIGURADO – DIAGNÓSTICO DE FRATURA DE COLUNA TORÁCICA – O JUIZ É DOTADO DE PODERES INSTRUTÓRIOS, PODENDO APRECIAR LIVREMENTE AS PROVAS, ATENDENDO AOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, E NÃO ESTÁ ADSTRITO APENAS AO LAUDO PERICIAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A responsabilidade do hospital é objetiva, a qual resta afastada em caso de comprovação de que o defeito inexiste ou decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º. Não obstante isso, nos casos em que o defeito na prestação do serviço do hospital não decorre de ato próprio da instituição, mas está ligado à atuação técnico-profissional do médico a ela vinculado, a responsabilidade do nosocômio passa necessariamente pela comprovação da culpa do seu agente.* ***2- A teor dos arts. 130 , 131 e 436 do CPC , o juiz é dotado de poderes instrutórios, podendo apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, e não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar a sua convicção por outros elementos ou fatos provados nos autos*** *. 3-A alta prematura concedida à*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

> *autora, decorrente de erro de diagnóstico (não constatação de fratura na coluna torácica) caracteriza a prática de ato ilícito. O nexo de causalidade, nesse sentido, decorre do agir descuidado do profissional da saúde. 3. Caracterizado o dano moral in re ipsa. O abalo sofrido pela parte autora inegavelmente extrapola os limites da normalidade. Relativamente a este, decorre da dor e do sofrimento gerados pela ausência de tratamento adequado, bem como da angústia de que este fato tenha agravado ainda mais a lesão. Configurada a violação do direito subjetivo da parte e, consequentemente, dano de natureza extrapatrimonial. 4. Verificada a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia, ocorrida por ocasião do erro de diagnóstico, ocasionando danos que poderiam ter sido evitados, tal fato importa no dever de indenizar os danos materiais comprovados nos autos".* Destaquei (TJMS - AC: 00390825020088120001 MS 0039082-50.2008.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/07/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2015).

Ouvido como informante na audiência de f. 624, o médico Renato Ximenes afirmou que a autora, quando chegou ao seu consultório, estava com a barriga enorme, dificuldade de locomoção e de respirar. Cita que fez uma drenagem paliativa para aliviar as condições e logo seguida internou a requerente, pois apresentava síndrome hipertensiva com risco de morte, por eclâmpsia ou parto prematuro. Relata que após o cirurgia a autora continuou em estado grave e continuou internada, com a estabilização de suas condições somente após o parto. Informou que o caso é raro e o acompanhamento da autora não foi adequado, pois não foi oferecido tratamento precoce, tampouco ocorreu avaliação para o seu transporte até a Curitiba/PR, certo que chegou ao seu consultório em estado grave.

Pelos elementos coligidos nos autos, conclui-se que não havia no domicílio da autora tratamento disponível, a indicação do médico Dr. Renato Ximenes ocorreu pelos médicos credenciados do plano de saúde réu que atendiam a autora e embora a ré tenha indicado outro profissional em Curitiba/PR, a autora estava em Campinas/SP, a requerida sequer cogitou/avaliou como faria o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

transporte de uma localidade para outra e por fim, a situação era de emergência.

Tais fatores indicam que com o agravamento do quadro, não se podia exigir da requerente conduta diversa, que não fosse o procedimento já indicado, no local em que estava, pois corria risco de vida e havia a possibilidade de salvar um dos filhos gêmeos.

Cumpre ressaltar que os valores dos procedimentos por ambos os profissionais são aproximados, pois o orçamento apresentado pelo Dr. Renato Ximenes foi de R$ 84.100,00 (f. 82-3) e pelo Dr. Rafael Frederico Burns, indicado pelo plano de saúde réu foi de R$ 72.000,00 (f. 276), a demonstrar que a diferença não cobreria o risco de vida envolvido, em razão da emergência.

Portanto, a autora deve ser ressarcida de forma integral do custeio do procedimento cirúrgico indicado na inicial com o Dr. Renato Ximenes, no Hospital Madre Theodora, em Campinas/SP, ocorrido em 24.8.2019, assim como os custos da internação até sua recuperação. Por oportuno, cita-se:

> *"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE EXAMES EM ESTABELECIMENTO NÃO CONVENIADO – AUSÊNCIA, NA REDE CREDENCIADA, DE HOSPITAL E PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM EQUIPAMENTO QUE SE MOSTROU DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA NO CASO – QUADRO DE ALTA COMPLEXIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA INTEGRAL DEVIDA – REEMBOLSO DOS VALORES DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO".* (TJMS. Apelação Cível n. 0806201-56.2023.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Waldir Marques, j: 02/10/2024, p: 07/10/2024).

> *"APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE EXAMES EM ESTABELECIMENTO NÃO CONVENIADO – AUSÊNCIA, NA REDE CREDENCIADA, DE HOSPITAL E PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM EQUIPAMENTO QUE SE MOSTROU DE ESSENCIAL IMPORTÂNCIA NO CASO – QUADRO DE ALTA COMPLEXIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ROL DA Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul*

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

> *ANS EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA INTEGRAL DEVIDA – REEMBOLSO DOS VALORES DEVIDO – RECURSO IMPROVIDO. - Restando demonstrada a alta complexidade do caso da autora, bem como a importância de realização de exames não existentes em hospital da rede credenciada, o plano de saúde deve ser compelido a custear o tratamento no estabelecimento não credenciado. - Em 21.09.2022, entrou em vigor a Lei n.º 14.454 que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. - Nos termos do art. 4.º, § 2.º, da Resolução 259/2011 da ANS, na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem. - Recurso conhecido e improvido".* (TJMS. Apelação Cível n. 0803491-83.2021.8.12.0018, Paranaíba, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/09/2022, p: 03/10/2022).

Os valores da condenação devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA/IBGE e aplicação da taxa Selic a partir da citação, em 23.8.2019 (f. 145) até o pagamento, por envolver relação contratual.

III) Dos danos morais:

No que pertine aos danos morais temos que os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem o dever de indenizar ao afirmarem que todo aquele que por ação ou omissão dolosa causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548, leciona sobre dano moral:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

> *chamados danos morais, de outro. O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

No caso em tela, não houve recusa na prestação de serviços pela parte ré, pois indicou profissional e hospital, entretanto, mesmo caracterizada a situação de emergência e concedida a tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico, em 23.8.2019, a ré comunicou o cumprimento da tutela somente em 20.5.2020 (f. 322-5), com a propositura de ação de cobrança em desfavor da autora pelo terceiro Esho Empresa de Serviços Hospitalares, autos nº 0813996-55.2019.8.12.0002, em apenso (f. 308-9), fatores que indicam transtornos, angústia e aflição, além dos meros aborrecimentos cotidianos.

Além disso, a jurisprudência se firmou no sentido de que a recusa indevida pelo plano de saúde à cobertura de procedimento/tratamento médico necessário à recuperação do segurado, ainda que fundada em cláusula contratual é abusiva e caracteriza dano moral **in re ipsa,** situação que se amolda ao presente feito, caracterizada pela demora e resistência ao pagamento, com a desnecessidade de comprovação do prejuízo. Confira-se:

> *"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 1. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO/MATERIAL NECESSÁRIO AO ÊXITO DO TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A CONTRATOS AJUSTADOS ANTERIORMENTE À LEI N. 9.656/1998. PRECEDENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese*

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

> *ora em foco, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades fáticas do caso – recusa indevida para cobertura de prótese (marcapasso) necessária ao sucesso do tratamento coberto no contrato –, reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, não sendo o caso de valoração da prova. 2. A recusa indevida pelo plano de saúde à cobertura de procedimento/tratamento médico necessário à recuperação do segurado, ainda que fundada em cláusula contratual, por se mostrar abusiva, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação do prejuízo. 3. Agravo interno desprovido".* (STJ. AgInt no AREsp 996042 / MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09.02.2017).

Portanto, presentes o dano, o nexo de causalidade e o dever da requerida em indenizar. Por conseguinte, deve-se analisar a quantificação do dano moral. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves leciona:

> "*Não tem aplicação, em nosso país, o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado...Por outro lado, deve o juiz, "ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244, 3ª Câm., j. 9-4-1992, Repertório IOB de Jurisprudência, n.3, p. 7679).* " (Responsabilidade civil, Carlos Alberto Gonçalves - 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 569-70).

Considerando os transtornos ocasionados pela conduta da parte ré e para coibir novos atos desta natureza, há que se arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00, por não ser fonte de enriquecimento e também não ser inócuo.

O valor da indenização por danos morais será

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.

corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ e os juros de mora pela taxa Selic desde a citação, conforme artigo 406, § 1.º, do CC.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, nos termos do artigo 12, inciso VI e 35C, ambos da Lei nº 9.656/98, julgo procedentes os pedidos formulados por **Thaisa Munike Costa de Oliveira** em desfavor de **Unimed de Dourados – Cooperativa de Trabalho Médico** para determinar: **a)** o reembolso das despesas médico-hospitalares de forma integral do custeio do procedimento cirúrgico indicado na inicial com o Dr. Renato Ximenes, no Hospital Madre Theodora, em Campinas/SP, ocorrido em 24.8.2019, assim como os custos da internação até sua recuperação, com atualização monetária pelo IPCA/IBGE; **b)** pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ. Com a aplicação de juros em ambos os valores a partir da citação em 23.8.2019 (f. 145), pela taxa Selic, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme artigo 406, § 1.º, do CC.

Para fins recursais, confirmo a tutela de urgência de f. 125-31.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e fixo honorários de advogado ao patrono da requerente em 10% do valor da condenação, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo profissional, tempo despendido e audiência de instrução, nos moldes do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Após trânsito em julgado, com o recolhimento das custas, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados (MS), 21 de outubro de 2024.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 21/10/2024 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0809964-07.2019.8.12.0002 e código qbqmp6vx.